Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 14ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0057189-59.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): MARIA CELINA GONCALVES ATHAYDE

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos etc.

MARIA CELINA GONÇALVES ATHAYDE, qualificada nos autos, através de advogado, interpôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, juntando documentos.

Aduziu a autora, que foi diagnosticada com osteoporose severa, com alto risco de fratura, **bem como Meningioma, tumor geralmente benigno, que surge nas membranas, que envolvem o cérebro e a medula espinhal, motivo pelo qual lhe foi prescrita medicação injetável de alto custo, Evenity (romosozumabe).**

Alegou, que antes mesmo da negativa do plano, desembolsava R$ 5.960,41, para a aquisição de 4 (quatro) caixas da medicação.

Requereu em sede antecipatória, que a ré fornecesse o tratamento medicamentoso com aplicação da droga EVENITY (romosozumabe) - 2 (duas) injeções em locais, pela via subcutânea, 1 (uma) vez por mês.

No mérito, além da confirmação, requereu a restituição dos valores desembolsados, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.

Citada, a ré BRADESCO SAÚDE S/A apresentou contestação de ID 174436954, na qual apresentou impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido em favor da parte autora.

No mérito, sustentou, em breve síntese, **que o medicamento solicitado possui natureza de uso domiciliar e estaria excluído da cobertura contratual e que a negativa de cobertura foi com base em cláusula contratual válida, a qual exclui expressamente fármacos não constantes no rol da ANS.** Defendeu, que não houve prática abusiva que justificasse indenização reparatória. Requereu a total improcedência dos pedidos autorais.

Réplica de ID 181121637.

O juízo determinou que a autora comprovasse a existência do meningioma aduzido na exordial, no despacho de id. 174052877 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAu **tendo a mesma esclarecido que a medicação era para fins de tratar a osteoporose, que precederá o tratamento do meningioma.**

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de outras provas, nada foi requerido.

Eis o breve relatório. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARIA CELINA GONÇALVES ATHAYDE, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Existindo preliminar, passo à sua apreciação.

De partida, no que diz respeito à impugnação à concessão da justiça gratuita em favor da parte autora, adiando, desde logo, que os argumentos da ré não merecem prosperar. Eis que, uma vez concedido o benefício, sua revogação depende de comprovação concreta da capacidade financeira pela parte adversa, recaindo o ônus da prova sobre quem a alega.

In casu, o impugnante deixou de apresentar qualquer documentação capaz de desconstituir a declaração de pobreza produzida pela autora, de forma que sua irresignação limita-se ao mero esforço argumentativo, que, como visto acima, não prospera.

Assim sendo, afasto a preliminar arguida.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia do presente feito diz respeito à obrigatoriedade de custeio do medicamento Evenity (Romosozumabe), pela operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, diante da negativa administrativa fundada na exclusão contratual, bem como da ausência do fármaco no rol de cobertura da ANS à época da solicitação.

Residindo ainda a controvérsia, **a respeito da finalidade do medicamento pugnado, eis que na exordial foi dito *ser a autora portadora de meningioma,* que é um de tipo de câncer***,* e por vias de consequências, se assim fosse, haveria previsão legal legitimando o tratamento com fármaco de uso domiciliar, diferentemente do diagnóstico de osteoporose, o qual não encontra respaldo na Lei, para fins de fornecimento de medicamento por plano de saúde.

No caso dos autos, a autora foi diagnosticada com meningioma e osteoporose severa, com alto risco de fratura, sendo-lhe recomendado pelo médico assistente, o início do tratamento por meio da medicação Evenity (romosozumabe), conforme se depreende da documentação de ID 171910855.

Pois bem, intimada a ser manifestar para fins de esclarecer ao juízo, a finalidade do tratamento medicamentoso pugnado, a autora esclareceu de forma categórica ser para fins de tratar a osteoporose e não o meningioma.

Nestes termos, a decorrência jurídica mostra-se distinta, tendo em vista a Lei nº. 9.656/98, que por sua vez, no art. 10, VI, estabelece ser de cobertura cogente, na segmentação ambulatorial, **apenas o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliares previsto no art. 12, I, c, de referida legislação, que são justamente àqueles necessários à cura oncológica**. Vejamos:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> [...]
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas

> as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, SEGUNDO AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS MÍNIMAS:
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial:
>
> (...)
>
> c) **COBERTURA DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL, INCLUINDO MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO E ADJUVANTES**;

A Resolução Normativa nº. 465/2021 da ANS, em seu art. 18, IX e X, só garantem também, tratamento ambulatorial para as hipóteses de tratamento de câncer. Vejamos:

> Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:
>
> [...]
>
> IX - **quimioterapia oncológica ambulatorial**, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;
>
> X - **medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar**, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características

O remédio requerido pela autora, entretanto, nos termos posteriormente esclarecido nos autos, conforme id.175242589 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProces busca tratamento de osteoporose. Tendo o juízo, ao deferir anteriormente a medida antecipatória pugnada, sido direcionado pelo diagnóstico do *meningiona*, o qual nos termos já ditos, posteriormente restou esclarecido pela própria autora, com a determinação de despacho neste sentido
(174052877 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcess **aduzindo que o remédio objeto da lide tinha o propósito de tratar a osteoporose,** diferentemente do que se retratou na exordial.

Restando assim, ausente a obrigatoriedade no fornecimento de medicamento para fins de uso domiciliar, por parte do plano de saúde, d**evendo nestes termos, ser pugnado ao Estado, em caso de sua necessidade**, aliada a ausência de recursos financeiros para tanto.

Tudo, nos termos acima transcritos.

Neste diapasão, torno sem efeito a antecipação de tutela deferida no id. , por ter sido concedida tendo como base doença cancerígena, a qual não se mostrou ser o vetor de indicação do medicamento ora pugnado.

Não há, portanto, ilegalidade na negativa aposta pela demandada.

Ante todo o exposto e considerando tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido exposto na exordial, ao passo que torno sem efeito a tutela anteriormente concedida no id.174052877 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProces e extingo o presente feito, com julgamento do mérito, pautada no art. 487, I, do CPC.

Oficie-se ao Gabinete da 4a Câmara Cível, tendo em vista a existência de Agravo de Instrumento com decisão concessiva de liminar referente ao presente feito, nos termos do id. 1 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitai

.

Condeno a autor nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Havendo a interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, remetendo-se – em seguida – os autos ao E.TJPE para processamento e julgamento.

P.R.I.C.

Recife, 17 de junho de 2025.

Crystiane Maria do Nascimento Rocha

Juíza de Direito Substituta.

Assinado eletronicamente por: CRYSTIANE MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
17/06/2025 14:18:21
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 204449504

25061714182082600000199145921

IMPRIMIR GERAR PDF